类风湿关节炎的关节特点 （二）《外科学》10 版教材 P756（符合≥4 条标准）

晨僵≥1 小时（≥6 周），≥3 个关节肿胀（≥6 周），腕/掌指/近端指间关节至少 1 个肿胀（≥6 周）

对称性关节肿胀（≥6 周），皮下类风湿结节

手腕关节 X 线骨质疏松或骨侵蚀，类风湿因子阳性（滴度＞1:32）

真题解析·类风湿关节炎（内科+外科）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

内科学

1.2014N75 A 以下出现关节痛的疾病中，休息后症状加重的是

A.强直性脊柱炎

B.系统性红斑狼疮

C.痛风

D.骨关节炎

2.2015N76 A 不属于类风湿关节炎的诊断标准是

A.晨僵

B.关节肿

C.关节畸形 三不

D.类风湿结节

3.2018N56 A 与类风湿关节炎病情活动程度无关的实验室检查结果为

A.血红蛋白下降

B.血小板减少 Felty综合征:脾大+全血细胞↓(但类风湿活动期血小板可↑)

C.RF 滴度升高

D.血沉增快

ttsx	SLE	类风湿
关节软骨破坏	多无 非侵蚀性关节炎	多有
肾	多受累	少受累
补体 C_3	↓（典型的血管炎） 工型循环免疫复合物 工工型补体替代途径异常激活 补体 C_3↓：急性肾炎（8 周内恢复）、急进性肾炎II型、系膜毛细血管性肾炎、SLE、肝病等 SLE可继发二型急进性肾炎 肝脏产生C3	多正常或轻度↑ 伴血管炎可↓ 一般小剂量GC 但继发血管炎要中到大量GC
活动期血小板	↓（抗血小板抗体、抗磷脂抗体、骨髓巨核细胞成熟障碍）类似ITP	↑
与活动性无关	ANA、Sm、SSA、SSB 等	关节畸形等
治疗	糖皮质激素+免疫抑制剂	NSAIDs 或糖皮质激素 +DMARDs

4.2019N56 A 以下关于类风湿关节炎（RA）患者实验室检查临床意义的描述中，正确的是

A.RF 阴性可排除 RA 诊断

B.RF 对诊断 RA 的特异性明显高于抗 CCP 抗体

C.抗 CCP 抗体有助于 RA 的早期诊断

答案：1-4 A C B C